

Información Paciente

Nombre : David Fabian Contreras Araya
Edad : 52a 9m 28d
Dirección : Pje Alto Consistorial 0698

Rut : 11.394.954-6
Fecha Nacto: 20/10/1969
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2208981
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 4579 1312

N° Epicrisis
316955

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 11/07/2022 19:50

Días Estadía: 37

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 17/08/2022 08:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

AM: ICC FE 25% CF 3, cardiopatía coronaria, DHC etiología no precisada (OH vs cardiaco), policonsumo suspendido 2018. 2 Hospitalizaciones recientes por ICC descompensada (1 en contexto de colección postquirúrgica inguinal izq, otra contexto celulitis EII + NAC). Ultima 04/06 dado de alta a UHD (06/06) para tratamiento con linezolid que completa 09/06) Medicamentos: Enalapril, AAS, Furosemida, no recuerda el resto al momento del ingreso

- Alergias: Niega

- Antecedentes Quirúrgicos: Hernioplastia inguinal derecha hace 1 mes aprox.

Inmunizaciones: 4 dosis de COVID-19, Influenza (-)

Fcos: FSM, CVDL, Espiro, PCT, Meto, Quetiapina, clona, TACO.

Ecocardiograma (17.05.22) FEVI : 26% , VI severamente dilatado, AI moderadamente dilatada, IM leve, Cavidades derechas dilatadas Función sistólica deprimida, HTP 61 mmhg

En TACO por sospecha de trombos en aurícula (informados en TAC, Ecocardio en hosp con "mala ventana", pendiente ECOTE).

CF III basal. Historia de 1 día de evolución de disnea y dolor torácico súbito en contexto de esfuerzo físico de baja intensidad. No asociado a síntomas neurovegetativos.

Ingres a servicio de urgencia en malas condiciones generales. Con clínica compatible con ICC + EPA y mala perfusión global.

Destaca en ecoscopia de ingreso hipokinesia global predominio pared anterior y septum. VCI pletórica

Sin líneas B patológicas, FEVI 10% aprox PAPS 65 aprox.

En lab de ingreso destaca lactato 132, Alza de transaminasas (hepatopatía congestiva) y falla renal con crea hasta 2.1

Se realiza angioTAC de tórax que informa TEP subsegmentario en LID.

Dado shock cardiogénico y falla ventilatoria se decide apoyo con noradrenalina y milrinona, manejo avanzado de vía aérea e ingreso a UCI.

Evolución en UCI:

Hemodinámica: Ingres a con signos de mala perfusión global y requerimientos de DVA NA 0.3 + Milrinona 0.25 ug/k/min. Con evolución lenta, logrando mejor perfusión clínica, caída de lactato y diuresis espontánea apropiadas durante estadía. Se logra descenso paulatino de BIC de noradrenalina hasta su suspensión en su día 15 de estadía en UCI. En estudio complementario,

Fecha Epicrisis : 17/08/2022 08:12

Fecha Última Actualización: 17-08-2022 8:12:44

Página 2 de 4

se constató TEP subsegmentario como factor contribuyente a descompensación. Desde entonces con BIC de heparina. A la fecha se mantiene estable, macrohemodinamia autosostenida. No ha presentado arritmias durante estadía. Milrinona suspendida hace 48 horas.

Respiratorio: Ingresa conectado a VMI, en modo controlado por volumen y con parámetros protectores. Sin conflicto ventilatorio desde su ingreso, manteniendo PAFI > 300 de forma persistente en controles iniciales. Se suspende sedoanalgesia el 19/07 cambiando de forma precoz a presión soporte. Se realizó prueba de ventilación espontánea el 27/07 que es bien tolerada, por lo que se extuba ese mismo día manteniendo apoyo de milrinona. Con salida a CNAF que se intercala con VMNI. Actualmente weaning consolidado. Destetado hace 24 horas de VMNI, titulando O2 por naricera a la baja.

Infeccioso: A su ingreso a la unidad destaca extremidad inferior izquierda aumenta de volumen, eritematosa y con vesículas no hemorrágicas. Dado diagnóstico reciente de celulitis en misma extremidad con tratamiento con linezolid se decide reinicio de terapia. Con mejoría clínica de extremidad inferior pero con parámetros inflamatorios persistentemente aumentados asociado a febrículas hasta 37.8°C. Se PAN cultiva (15/07) y se inicia tratamiento con imipenem, posteriormente cultivos (+) CAET KPN BLEE + K. Oxytoca MS y OC (+) KPN BLEE. Completó en total 8 días de linezolid (suspendido) + 12 de imipenem. Luego, el 29/07 evoluciona con peak febril se pancultiva y se escala a Meropenem+Vancomicina. Con buena respuesta infectológica. desarrollo de BGN en HC. Pendiente etapificación y resultado del resto de los cultivos. Se ha mantenido afebril desde entonces.

Renal: Ingresa con AKI KDIGO 1. Tras inicio de drogas vasoactivas logra mejor perfusión global y descenso gradual de crea hasta normalización (último control 1.18 01/08). No requirió TRR.

Se trasladó a UTIM para weaning y rehabilitación.

FI SU CASR: 11/07/2022

FI UTIM: 01/08/2022

FI Sala: 03/08/2022

Días de hospitalización: 32

ATB: Imipenem (11) - Vancomicina oral (7) - Vancomicina EV (1)

Diagnósticos Actuales:

1. Sepsis de foco hematógeno y abdominal
1. Infección del torrente sanguíneo asociada al CVC por KPN BLEE
2. SDA intrahospitalario, sospecha diarrea por CD.
2. Shock cardiaco con FOM resuelto
1. MCPD FEVI 26% conocida y CF III
2. Cura inotrópica con Milrinona
3. VMI 11/7 al 29/7 por shock profundo
3. Sd post-UCI
1. Miopatía y disfagia del paciente crítico
2. Delirium hipoactivo
4. TEP sub segmentario anticoagulado

Antecedentes: IC FEVI 25%, miocardiopatía dilatada, HTP, DHC etiología no precisada, policonsumo suspendido 2018

Hemodinamia: Estable, vigilar.

Respiratorio: TEP sub segmentario anticoagulado con HBPM. Se difiere TACO hasta mayor estabilidad.

Cardiológico: ICC conocida en contexto de MCPD por OH, con FE severamente deprimida (FEVI 26% mayo/22).

Ingresa en contexto de shock cardiaco, ameritó VMI dentro de manejo del shock y cura inotrópica con DVA altas dosis y Milrinona.

Actualmente en ajuste de terapia médica óptima.

Se solicitó ecoTT.

Se evaluará DAI/TRC según evolución. Además evaluar posibilidad de uso de Entresto/iSLGT2 en control ambulatorio

Fecha Epicrisis : 17/08/2022 08:12

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 17-08-2022 8:12:44

Página 3 de 4

Infeccioso: Ha cursado múltiples hits infecciosos:

- Celulitis EII tratada con linezolid
- NAAS x K. Oxytoca + ITU x KPNE BLEE. Manejada con imipenem (12).
- ITS CVC x KPNE BLEE en tto con imipenem (7/7)
- Sd. diarreico por CD en tto con vancomicina (7/10)
- 11/08 se inicia nuevamente Vanco EV dado persistencia de fiebre, y se mantiene con Imipenem, (p) definir con infectología duración de terapia

Desde el 09/08 nuevamente febril.

- 09/08 HC 1 y 2 (p)
- 09/08 SU no inflamatorio, UC (-)

Por lo tanto:

- Pendiente TAC TAP en búsqueda de complicaciones u otro foco.

Renal: AKI multifactorial recuperada. No es conflicto actual.

Gastro: Paciente con sospecha de DHC por imágenes, estudio AI y viral negativo, sin clínica de cirrosis y pruebas hepáticas levemente alteradas (que se explica también pro falla cardíaca). Impresiona DHC incipiente, de momento en seguimiento, posible etiología sería cirrosis cardíaca vs OH.

Rehabilitación:

- FNA: Disfagia Fils 4. Régimen 0 x boca, en estimulación. Se mantiene SNG y rehabilitación por FNA.
- KNT: Activar en cama, en planes de progresión de activación durante la semana según estabilidad.
- Psiqu: delirium actualmente hipoactivo, en titulación de olanzapina a la baja

Manejo hasta UTIM, DVA hasta 0.3, no RCP, no IOT

Se entrega información a familiar de forma presencial, recibe conforme

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia cardíaca global -
OTRAS SEPSIS ESPECIFICADAS -
Choque cardiogénico -
Choque séptico -

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en malas condiciones generales. Mala evolución clínica.
HDN inestable, con requerimientos de NAD y epinefrina en dosis altas. Hiperlactacidemia de 118.
Disneico, polipneico, con estertores difusos bilaterales. Con requerimientos de FiO2 al 100%. En apoyo con BIC de fentanilo.
Afebril. Evoluciona con compromiso de conciencia a sopor profundo.
Se recibe laboratorio: Hb 8.8 / lactato 118 / TUS 72 / Crea 2.4 / BUN 63 / Na 145 / K 8.3 / CI 114
pH 7.2 / pCO2 24 / HCO3 9.5
Se indica gluconato de calcio y bicarbonato 2/3 M.

En suma, paciente con falla hemodinámica, cardíaca, respiratoria, renal y compromiso del sensorio.

Familiares acuden presencial. Se da información sobre gravedad. Reciben conformes.

En su techo terapéutico.

Fallece a las 03:20 AM

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 17/08/2022 08:12

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:11

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Martín Aburto Marchant
Becado/Residente

José Ignacio Navarrete Zavala
Médico Tratante (Staff)